Клинические рекомендации

Расщелина верхней губы и нёба

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**Q35** — Расщелина неба [волчья пасть] **Q36** — Расщелина губы [заячья губа] **Q37** — Расщелина неба и губы [волчья пасть с заячьей губой]
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.06.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Общероссийская общественная организация «Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1050_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Жалобы и анамнез 5

3.2 Консультации специалистов 5

3.3 Экссудативный средний отит 5

3.4 Риноскопия 5

3.5 Фарингоскопия 5

3.6 Ультразвуковое скрининговое исследование при беременности 5

3.7 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5

4. Лечение 6

4.1 Консервативное лечение 6

4.2 Хирургическое лечение 6

4.3 Медицинская реабилитация 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Показания к госпитализации 8

5.2 Диспансерное наблюдение 8

6. Источник и актуальность **8**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Расщелина губы и (или) нёба является тяжёлым пороком развития челюстно-лицевой области с нарушением непрерывности верхней губы, альвеолярного отростка и нёба; порок сопровождается значимыми нарушениями питания, речи, слуха и носового дыхания.
- Расщепление и неправильное прикрепление нёбных мышц вызывают дисфункцию слуховой трубы, поэтому всем пациентам показаны наблюдение и лечение у оториноларинголога, при необходимости тимпанотомия, для профилактики и лечения экссудативного среднего отита и сохранения слуха.
- Реабилитация длится с рождения **до подросткового возраста** и требует участия команды:
  1. неонатолог и педиатр;
  2. челюстно-лицевой хирург и ортодонт;
  3. генетик;
  4. оториноларинголог;
  5. логопед и психолог.
- **Сроки операций**
  1. первичная хейлоринопластика: **старше 3–6 месяцев**, в течение первого года жизни;
  2. щадящая уранопластика при расщелине вторичного нёба: **1–2 года**;
  3. расщелина мягкого и твёрдого нёба: пластика мягкого нёба в **1–2 года**, щадящая уранопластика **после 3–4 лет**;
  4. устранение нёбно-глоточной недостаточности: **с 6 лет**;
  5. пластика альвеолярного отростка: **8–10 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Расщелина верхней губы, альвеолярного отростка и нёба представляет собой врождённый порок развития с нарушением в средней зоне лица.

Составляющие порока

1. расщепление губы на два или три фрагмента;
2. деформация хрящевого отдела носа;
3. порочное прикрепление и нарушение функции пучков круговой мышцы рта;
4. дефект альвеолярного отростка верхней челюсти.

При расщелине нёба

1. сообщение полости рта с полостью носа через дефект по средней линии нёба;
2. неправильное расположение и прикрепление мышц мягкого нёба;
3. расширение среднего отдела глотки и укорочение мягкого нёба.

Реконструктивные операции

1. уранопластика: при расщелине твёрдого нёба;
2. пластика мягкого нёба: при расщелине мягкого нёба;
3. хейлоринопластика: при расщелине верхней губы и деформации хрящевого отдела носа.

Нарушения функций

1. питание: сосание невозможно из-за сообщения полостей носа и рта, затем нарушается жевание;
2. речь: несостоятельность велофарингеального сфинктера, невнятная тихая речь с носовым оттенком, задержка речевого развития;
3. слух: расщепление и неправильное прикрепление нёбной мускулатуры вызывают дисфункцию слуховой трубы;
4. носовое дыхание: деформация концевого и костно-хрящевого отдела носа нарушает воздушный поток и способствует патологии ЛОР-органов.

2.2 Этиология и эпидемиология

Порок имеет мультифакторное происхождение: генетическая предрасположенность или новая мутация сочетается с неблагоприятными факторами: физическими, химическими (дефицит питания, гипо- и гипервитаминоз, тератогенные вещества и лекарства, алкоголь, наркотики), биологическими (грипп, краснуха, герпес, токсоплазмоз).

Расщелины занимают 3–5-е место среди врождённых пороков и первое (87%) среди пороков лица; частота составляет 0,6–1,6 на 1000 новорождённых, в России около 1 на 650–700.

2.3 Классификация

1. односторонняя расщелина верхней губы: скрытая, неполная, полная;
2. двусторонняя расщелина верхней губы (симметричная, асимметричная): скрытая, неполная, полная;
3. односторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка: неполная, полная;
4. двусторонняя расщелина верхней губы и альвеолярного отростка: неполная, полная;
5. односторонняя полная расщелина верхней губы и нёба;
6. двусторонняя полная расщелина верхней губы и нёба;
7. расщелина нёба: субмукозная (скрытая), неполная, полная.

2.4 Клиническая картина

При полной расщелине губы всегда есть деформация кожно-хрящевого отдела носа. При односторонней расщелине крыло носа на стороне расщелины уплощено и растянуто, кончик носа смещён в больную сторону, перегородка носа выгнута в здоровую. При двусторонней расщелине перегородка носа короткая, кончик уплощён, крылья растянуты.

Скрытая (субмукозная) расщелина нёба малозаметна: иногда вдавление слизистой оболочки между половинами мягкого нёба, несращение костных пластинок твёрдого нёба, нёбо укорочено. Характерны открытая гнусавость и нарушения артикуляции, иногда компенсаторные движения мимических мышц и крыльев носа.

При полной расщелине мягкого и твёрдого нёба видны носовые раковины, слизистая оболочка их обычно гипертрофирована; мягкое нёбо укорочено, глоточное кольцо расширено, мышцы мягкого нёба недоразвиты.

---

3. Диагностика

Диагноз клинический и устанавливается на основании визуального осмотра, антропометрии, рентгенологических и ультразвуковых исследований. Специфической лабораторной диагностики нет: исследования назначает генетик, предоперационный комплекс исследований назначает педиатр.

3.1 Жалобы и анамнез

Во всех возрастных периодах уточняют

1. наследственный анамнез (патология челюстно-лицевой области);
2. воздействие тератогенов в I триместре беременности;
3. нарушения жевания, речи, дыхания и слуха, эстетический дефект.

3.2 Консультации специалистов

1. педиатр: общесоматический статус, росто-весовые показатели, сопутствующая патология перед плановой операцией;
2. челюстно-лицевой хирург: диагноз и план лечения;
3. оториноларинголог: состояние ЛОР-органов, профилактика осложнений;
4. ортодонт: состояние прикуса, ортодонтическая коррекция до и после операций;
5. генетик: генетическая патология, сопутствующие синдромы, планирование беременностей.

Оперативные вмешательства в подавляющем большинстве плановые, поэтому перед операцией пациента тщательно обследуют и компенсируют всю сопутствующую патологию; перед любым оперативным вмешательством оценивается степень анестезиологического риска.

3.3 Экссудативный средний отит

Пациентам с расщелиной губы и нёба показаны наблюдение и лечение у оториноларинголога, при необходимости тимпанотомия, для профилактики и лечения экссудативного среднего отита и сохранения слуха. Задачи оториноларинголога по возрастным периодам приведены в разделе «Медицинская реабилитация».

3.4 Риноскопия

Показания

1. дети **с 7 лет**: выявление искривления перегородки носа и сообщения полости рта с полостью носа.

После риноскопии показана консультация оториноларинголога.

3.5 Фарингоскопия

Показания

1. дизартрия: медико-логопедическое исследование и разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации.

Фарингоскопию выполняют челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог, заключение даёт логопед.

3.6 Ультразвуковое скрининговое исследование при беременности

Показания

1. беременные **на 19–21-й неделе**: первичное выявление расщелин губы и нёба и других пороков развития лица, мозга, сердца и скелета.

3.7 Компьютерная томография челюстно-лицевой области

Показания

1. дети **6–11 лет**: оценка дефекта переднего отдела твёрдого нёба, положения фрагментов верхней челюсти и планирование размера костного трансплантата;
2. подростки **12–18 лет**: оценка соотношения верхней и нижней челюстей и определение показаний к ортогнатической операции.

4. Лечение

4.1 Консервативное лечение

Детям **0–3 месяцев** применяют ортодонтические аппараты (нёбные пластинки): они облегчают кормление, разделяют полости рта и носа и корригируют деформацию челюстей до операции. Затем проводится предхирургическое ортодонтическое лечение.

Логопедическая коррекция начинается в дооперационном периоде и продолжается после уранопластики. Семье показано психологическое консультирование для снижения тревожности.

4.2 Хирургическое лечение

Принципы

1. выбор метода по типу расщелины, степени гипоплазии и деформации окружающих структур;
2. восстановление анатомической и функциональной целостности зоны расщелины;
3. этапность лечения с учётом соматического статуса;
4. командный подход: челюстно-лицевой хирург и ортодонт.

Первичная хейлоринопластика устраняет дефект губы и деформацию носа. Рекомендуемый возраст: **старше 3–6 месяцев**, в течение первого года жизни.

Противопоказания к ранней пластике губы

1. сопутствующие врождённые пороки развития;
2. родовая травма;
3. постнатальная энцефалопатия;
4. анемия;
5. гипотрофия.

В этих случаях хейлоринопластику выполняют позднее, при достижении ремиссии.

Пластика нёба: рекомендуемый возраст

1. расщелина вторичного нёба: щадящая уранопластика в **1–2 года**;
2. расщелина мягкого и твёрдого нёба: два этапа, пластика мягкого нёба в **1–2 года**, щадящая уранопластика **после 3–4 лет**.

Нёбно-глоточную недостаточность устраняют для формирования правильной речи после консультации логопеда и оториноларинголога; коррекция целесообразна **с 6 лет**.

Пластику альвеолярного отростка выполняют в **8–10 лет** после ортодонтической подготовки.

Для устранения дефектов и деформаций после ранее проведённых операций применяют реконструктивную хейлоринопластику, хейлориносептопластику и повторную уранопластику.

Сроки корригирующих операций

1. верхняя губа: в любом возрасте;
2. кожно-хрящевой отдел носа: полная коррекция в **14–16 лет**;
3. деформация пирамиды носа: вмешательство откладывают **до 17 лет**.

Сроки коррекции носа определяют индивидуально с учётом тяжести патологии и социальной адаптации ребёнка.

Операции после 18 лет

1. ортогнатическая операция;
2. вторичная хейлоринопластика и риносептопластика;
3. повторная уранопластика и устранение нёбно-глоточной недостаточности;
4. пластика альвеолярного отростка, дентальная имплантация.

Задачи хирургического лечения односторонней расщелины губы и нёба

Проблема	Методики
смещение основания колумеллы и перегородки носа в здоровую сторону	мобилизация и репозиция переднего края четырёхугольного хряща (методики Millard, Козина, Delaire)
деформация крыльного хряща на стороне расщелины	мобилизация крыльного хряща, поднадкостничная мобилизация мышц назолабиального комплекса
укорочение нёба, дистопия мышц нёбно-глоточного кольца	удлинение нёба, восстановление мышечной структуры: Z-пластика по Furlow, методики Фроловой, Иванова — Агеевой, Veau — Wardill — Killner, Bardach

4.3 Медицинская реабилитация

Новорождённым показаны специальные приспособления для кормления. Зондовое питание не рекомендуется: оно подавляет рефлекс глотания и усугубляет недоразвитие челюстей и мышц мягкого нёба.

Показания к зондовому питанию

1. тяжёлая сопутствующая соматическая патология;
2. недоношенность;
3. незрелость новорождённого.

Первоочередной задачей является обучение родителей кормлению сцеженным грудным молоком или смесями и профилактика аспирации. В первые недели жизни необходим ежедневный контроль массы тела.

На первом году жизни росто-весовые показатели контролируют регулярно, **1 раз в неделю**, корректируя метод кормления и устраняя дефицит массы тела.

С периода новорождённости **до 18 лет** оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог на каждом этапе оценивают состояние среднего уха, рото- и носоглотки и слух; лечение симптоматическое, по показаниям.

Оценка ЛОР-органов и слуха по возрастным периодам

Возрастной период	Хирургический этап	Оценка ЛОР-органов и слуха
Период новорождённости	раннее ортодонтическое лечение в зависимости от типа расщелины	оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог оценивают среднее ухо, рото- и носоглотку, слух; симптоматическое лечение по показаниям
1–4 месяца	подготовка к операции, первичная хейлоринопластика (хейлориносептопластика)	оценка среднего уха, рото- и носоглотки, слуха; выявление противопоказаний к операции; симптоматическое лечение по показаниям
5–12 месяцев	первичная хейлоринопластика; подготовка к одноэтапной уранопластике или первый этап пластики нёба при двухэтапной операции	оценка среднего уха, рото- и носоглотки, слуха в послеоперационном периоде

Возрастной период	Хирургический этап	Оценка ЛОР-органов и слуха
12 месяцев – 2 года	одноэтапная уранопластика, второй этап пластики нёба при двухэтапной операции	сурдолог-оториноларинголог оценивает среднее ухо, рото- и носоглотку, слух в послеоперационном периоде
2–5 лет	устранение нёбно-глоточной недостаточности и дефектов твёрдого нёба, реконструктивная хейлоринопластика (хейлориносептопластика) по показаниям	сурдолог-оториноларинголог оценивает среднее ухо, рото- и носоглотку, слух в послеоперационном периоде
6–11 лет	устранение расщелины альвеолярного отростка и нёбно-глоточной недостаточности, хейлоринопластика, уранопластика	оценка среднего уха, рото- и носоглотки, слуха в послеоперационном периоде
12–18 лет	устранение сочетанной деформации челюстей, расщелины альвеолярного отростка и нёбно-глоточной недостаточности, хейлоринопластика, дентальная имплантация	оториноларинголог оценивает среднее ухо, рото- и носоглотку в предоперационном периоде

> В таблице 7 второй этап пластики нёба при двухэтапной операции отнесён к периоду от 12 месяцев до 2 лет, тогда как в разделе 3.2 щадящая уранопластика вторым этапом рекомендована после 3–4 лет.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Медицинская помощь оказывается в стационарных условиях, в том числе высокотехнологичная. Госпитализация плановая, поэтапная, согласно алгоритму лечения.

5.2 Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение проводится **с рождения до 18 лет** включительно.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Одно- и двусторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 17.06.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июня 2029 года
Код в рубрикаторе	`1050_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки операций в разделе 3.2 и в приложении В («Информация для пациента») расходятся: пластика альвеолярного отростка в 8–10 лет и «начиная с 7 лет», хейлоринопластика «старше 3–6 мес» и «в течение первых четырех-шести месяцев», уранопластика в 1–2 года и «от 13 месяцев».

- Второй этап пластики нёба при двухэтапной операции в таблице 7 отнесён к возрасту от 12 месяцев до 2 лет, в разделе 3.2 рекомендован после 3–4 лет.